UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Pédiatrie
Douleur testiculaire
avec patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : CUDEL Aurélia **Date de rédaction : décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 100 – Douleur testiculaire

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Examen clinique

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Annonce

Attendus d'apprentissage de la situation abordée

1- Réaliser l'examen urologique d'une bourse douloureuse en adoptant une attitude approprié et identifier les principales étiologies

2- Expliquer au patient et/ou à son entourage l'intérêt d'un traitement médical et/ou chirurgical

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table et 2 chaises

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : Vous êtes le parent de Mathéo, un garçon de 13 ans, qui s'est réveillé ce matin avec une douleur au niveau de son testicule droit. Vous l'avez donc amené aux urgences pédiatriques. Un interne en médecine va vous recevoir.

Identité de l'enfant	Prénom : Mathéo Age : 13 ans
Identité du parent	Nom : MERCREDI Age : 38 ans Hôtesse de l'air Mariée, 2 enfants
État d'esprit/ comportement du parent	Posture assise Angoisse : forte
Déroulement du scénario	Vous êtes assise. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : « Je viens vous voir car Mathéo a très mal au niveau de son testicule droit et ça m'inquiète beaucoup » .
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Après que l'étudiant est expliqué la prise en charge de la pathologie, posez ces questions (s'il n'a pas déjà donné les réponses) : - On va devoir l'opérer ? - On ne fait pas de radio ? - Quels sont les risques de cette torsion ? - En quoi consiste la chirurgie ?

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en médecine générale aux urgences pédiatriques de Nice.
Vous avez reçu Mathéo, un garçon âgé de 13 ans, accompagné par sa mère, Mme GRINDA.
Vous avez examiné Mathéo qui présente une douleur au niveau de son testicule droit et vous évoquez une **torsion du cordon spermatique**.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. **Expliquer à la mère** la prise en charge de cette pathologie et répondre à ses questions.

2. **Enoncer à l'examinateur** les caractéristiques de la douleur et les caractéristiques cliniques d'un testicule faisant évoquer une torsion du cordon spermatique.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce **l'urgence chirurgicale**	
Explique la mise en jeu du **pronostic fonctionnel testiculaire** et/ou risque **d'ischémie** et/ou de **nécrose testiculaire**	
Explique qu'on ne fait **aucun examen complémentaire avant la chirurgie**	
Explique que, lors de la chirurgie, on va **détordre le testicule** et le **fixer** si le testicule est viable	
Énonce le **risque d'orchidectomie** ou **ablation du testicule** ou **d'enlever le testicule**	
Explique la **nécessité d'opérer également le testicule controlatéral** (*ou le testicule de l'autre côté*)	
Tache 2	
Énonce une **douleur brutale ET intense**	
Énonce une **irradiation** de la douleur vers la **région inguinale** et/ou la **fosse iliaque**	
Énonce une **douleur continue** et/ou **sans position antalgique**	
Énonce un **testicule augmenté de volume** (ou *œdème*)	
Énonce la **persistance de la douleur lors de la manœuvre de soulèvement** (ou *signe de Prehn négatif*)	
Enonce un **réflexe crémastérien négatif**	
Énonce **l'ascension du testicule** (ou *testicule ascensionné*) et/ou la **rétraction du testicule** (ou *testicule rétracté*) et/ou testicule horizontalisé	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à proposer une prise en charge	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient/aux aidants	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce **l'urgence chirurgicale**	1
Explique la mise en jeu du **pronostic fonctionnel testiculaire** et/ou risque **d'ischémie** et/ou de **nécrose testiculaire**	1
Explique qu'on ne fait **aucun examen complémentaire avant la chirurgie**	1
Explique que, lors de la chirurgie, on va **détordre le testicule** et le **fixer** si le testicule est viable	1
Énonce le **risque d'orchidectomie** ou **ablation du testicule** ou **d'enlever le testicule**	1
Explique la **nécessité d'opérer également le testicule controlatéral** (*ou le testicule de l'autre côté*)	1
Tache 2	
Énonce une **douleur brutale ET intense**	2
Énonce une **irradiation** de la douleur vers la **région inguinale** et/ou la **fosse iliaque**	1
Énonce une **douleur continue** et/ou **sans position antalgique**	1
Énonce un **testicule augmenté de volume** (ou *œdème*)	1
Énonce la **persistance de la douleur lors de la manœuvre de soulèvement** (ou *signe de Prehn négatif*)	1
Enonce un **réflexe crémastérien négatif**	1
Énonce **l'ascension du testicule** (ou *testicule ascensionné*) et/ou la **rétraction du testicule** (ou *testicule rétracté*) et/ou testicule horizontalisé	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à proposer une prise en charge	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient/aux aidants	

Devant une augmentation douloureuse du volume des bourses, il faut évoquer :

- **Une torsion du cordon spermatique** : toute bourse aiguë douloureuse est une torsion du cordon spermatique jusqu'à preuve du contraire et ce quel que soit l'âge. Une torsion du cordon spermatique se manifeste par une douleur scrotale aiguë, intense, unilatérale, brutale, volontiers nocturne. La douleur est continue, sans position antalgique et irradie vers la région inguinale, le long du cordon spermatique vers la fosse iliaque. Elle peut être accompagnée de nausées et de vomissements. A l'interrogatoire il est important de rechercher l'heure de début de symptômes. La bourse est douloureuse, augmentée de volume, parfois rouge et chaude. Lors des manœuvres de soulèvement la bourse reste douloureuse (signe de Prehn négatif). Le testicule est ascensionné, rétracté à l'anneau inguinal. Le réflexe crémastérien est absent.

Rang	A
Intitulé	Connaître les modalités du diagnostic d'une torsion du cordon spermatique
Description	None
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Cédric Lebâcle, Alice Faure
Ordre	15

- Le patient décrit une douleur aiguë, brutale, intense, continue, unilatérale, irradiant vers la région inguinale, sans position antalgique
- La torsion survient préférentiellement au moment des pics d'activité hormonal : nourrisson, adolescent entre 12 et 18 ans, (adulte jeune < 30 ans). La torsion du cordon spermatique est rare après 40 ans.
- L'interrogatoire recherche des facteurs de risque de torsion du cordon spermatique : traumatisme testiculaire, antécédent de torsion du cordon spermatique controlatéral

À l'examen physique (tableau souvent incomplet), on recherche :

- Signes positifs : une bourse douloureuse, augmentée de volume, un testicule dur, ascensionné, rétracté à l'anneau inguinal, horizontalisé. Le réflexe crémastérien est aboli, parfois on palpe le tour de spire. Nausées vomissements. Douleur soulagée après manœuvre de détorsion externe qui consiste à éloigner le pôle supérieur du testicule de la ligne médiane. Le sens de la détorsion est comme « un livre qu'on ouvre » : Le testicule droit doit être tourné dans le sens anti-horaire, alors que le testicule gauche doit être tourné dans le sens horaire.
- Signes négatifs : absence de fièvre, BU négative, absence d'écoulement urétral, signe de Prehn négatif, orifices herniaires libres, abdomen non douloureux, testicule controlatéral normal.
- Confirmé en peropératoire en observant des tours de spires ou traces de strangulation du cordon, ischémie testiculaire.

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-050-02-A
Item parent	Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme
Rang	A
Intitulé	Connaître l'urgence de la prise en charge d'une torsion du testicule, d'une fasciiite nécrosante des organes génitaux externes, d'un paraphymosis
Description	None
Rubrique	Identification de l'urgence
Contributeurs	Cédric Lebâcle, Alice Faure
Ordre	2

Torsion du cordon spermatique :

- La torsion du cordon spermatique est un diagnostic qui doit être évoqué devant toute douleur testiculaire aigue brutale survenant chez le nourrisson et l'adolescent entre 12 et 18 ans (pics d'activité hormonale). La torsion du cordon spermatique est rare après 40 ans.
- Elle entraîne une ischémie artérielle du testicule irréversible après 6 heures après le début de la douleur. C'est une urgence chirurgicale.
- Le risque est la mise en jeu du pronostic fonctionnel testiculaire avec ischémie et nécrose testiculaire. Ce risque est statistiquement corrélé à la durée de l'ischémie : plus la détorsion avec revascularisation est tardive, plus les fonctions endocrines et exocrines de la gonade sont mises en jeu.
- Néanmoins, la torsion du cordon spermatique est une urgence thérapeutique quel que soit la durée de l'ischémie.
- Il n'y a pas de place pour les examens complémentaires. En cas de doute, il faut effectuer une exploration chirurgicale. L'échographie-Doppler testiculaire peut être faussement rassurante. Elle est principalement prescrite pour éliminer les diagnostics différentiels ou en cas de suspicion de torsion ancienne (> 24h) mais ne doit jamais retarder la prise en charge thérapeutique.
- La manœuvre de détorsion externe a une place très limitée. Elle a pour but de soulager le patient et de réduire la durée de l'ischémie aiguë, sans retarder la prise en charge chirurgicale. Même en cas de succès (régression de la douleur) elle ne dispense pas d'une exploration chirurgicale urgente car il peut encore persister un ou plusieurs tours de spire sur le cordon spermatique.

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-050-07-B
Item parent	Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme
Rang	B
Intitulé	Connaître les principes généraux de la prise en charge d'une torsion du testicule, d'une fasciite nécrosante des organes génitaux externes, d'un phymosis, d'un paraphymosis
Description	None
Rubrique	Prise en charge
Contributeurs	Cédric Lebâcle, Alice Faure
Ordre	7

Torsion du cordon spermatique :

- La torsion du cordon spermatique est une urgence diagnostique et thérapeutique nécessitant une exploration scrotale chirurgicale sans délai afin de confirmer le diagnostic, lever l'ischémie en détordant le cordon spermatique et de réaliser une orchidopexie si le testicule parait viable. L'orchidopexie controlatérale peut être réalisée dans même temps ou ultérieurement. Si le testicule n'est pas viable une orchidectomie est nécessaire.
- Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge chirurgicale
- Le patient et sa famille doivent être prévenu du risque d'orchidectomie et d'atrophie testiculaire séquellaire si le testicule a pu être conservé.